



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 31 — Síndrome de Abstinência Alcoólica, Delirium Tremens e Encefalopatia de Wernicke

Reconhecimento e estratificação (CIWA-Ar, PAWSS), benzodiazepínico guiado por sintomas, tiamina antes da glicose, convulsão e delirium tremens, critérios de internação/UTI e articulação com o CAPS AD — cenário: pronto-socorro sem UTI

Código	PS-ND-31	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Cerca de 20% dos pacientes internados têm transtorno por uso de álcool, e a abstinência começa **dentro do PS** — 6 a 24 h após a última dose — muitas vezes em quem chegou por outro motivo (trauma, pneumonia, pancreatite, HDA). Não reconhecida, evolui para convulsão (6–48 h) e **delirium tremens** (48–96 h; mortalidade 5–15% sem tratamento). Duas regras não negociáveis: **tiamina antes de qualquer glicose** e **benzodiazepínico em dose suficiente, guiada por sintomas (CIWA-Ar), não em dose fixa "para dormir"**. A abstinência é também a janela para o cuidado: todo paciente sai com contato do CAPS AD.

Fontes de ancoragem: American Society of Addiction Medicine. **The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management, 2020** [ASAM 2020]; NICE CG100 (alcohol-use disorders: physical complications, 2010/2017) e CG115 [NICE]; Sullivan JT, et al. Assessment of alcohol withdrawal: the revised CIWA-Ar. Br J Addict 1989;84:1353 [CIWA-Ar]; Maldonado JR, et al. Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale (PAWSS). Alcohol 2014;48:375 [PAWSS]; Galvin R, et al. EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol 2010;17:1408 [EFNS 2010]; Rosenson J, et al. Phenobarbital for acute alcohol withdrawal (RCT). J Emerg Med 2013;44:592; Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium. N Engl J Med 2014;371:2109; **Associação Brasileira de Psiquiatria / ABEAD — Diretrizes para o tratamento da síndrome de abstinência do álcool** (Laranjeira R, et al.; edição vigente) [ABP/ABEAD — VERIFICAR]; Ministério da Saúde — Guia de Vigilância e RAPS/CAPS AD (Portaria 3.088/2011); Protocolos 04, 13, 14 e 23 desta série.

Convenção de confiança: doses conforme ASAM 2020/NICE/EFNS; **[VERIFICAR]:** tiamina IV (ampolas 100 mg) em quantidade, diazepam/lorazepam/midazolam, fenobarbital, escala CIWA-Ar impressa, CAPS AD de referência e fluxo de internação para desintoxicação.

1. Queixa — como o paciente chega

"Tremendo, suando, com o coração acelerado desde que parou de beber", "não dorme, está agitado, vendo bichos/ouvindo vozes", "convulsionou e nunca teve epilepsia", "confuso e agressivo no 2^o–3^o dia de internação", "nervoso porque não consegue parar". Ou chega por outra causa (queda, pancreatite, pneumonia, HDA, TCE) e a abstinência se instala no leito. Perguntar: **quanto bebe por dia e há quanto tempo** (doses; "pinga" ~40% — 1 dose = 14 g), **hora da última dose**, abstinências prévias e sua gravidade (convulsão? DT? internação?), benzodiazepínico em uso (tolerância cruzada), outras drogas, epilepsia, TCE recente, comorbidades (cirrose, DM, DPOC, cardiopatia), alimentação (desnutrição → Wernicke), tentativas de suicídio, suporte social.

Linha do tempo após a última dose

Tempo	Manifestação	Frequência
6-24 h	Abstinência menor: tremor, sudorese, ansiedade, insônia, taquicardia, hipertensão, náusea, cefaleia, hiperreflexia	Majoria
12-24 h	Alucínose alcoólica: alucinações (visuais/táteis/auditivas) com sensorio preservado e sinais vitais normais	10-25%
6-48 h (pico 24 h)	Convulsão de abstinência: tônico-clônica generalizada, única ou poucas, breve; estado de mal é raro (procurar outra causa)	5-15%; 1/3 evolui para DT se não tratado
48-96 h (até 7 dias)	Delirium tremens: confusão flutuante, desorientação, agitação, alucinações vívidas, hiperatividade autonômica grave (taquicardia, hipertensão, febre, sudorese profusa), tremor grosseiro	3-5% dos que se abstêm; mortalidade 1-5% tratada / 5-15% não tratada

2. Clínica — escalas, gravidade e diferenciais

2.1 CIWA-Ar — aplicar na chegada e a cada 1 h (se ≥ 10) ou 4-8 h (se < 10) [Sullivan 1989]

Item (0 = ausente)	Pontuação máxima e descritores	Item	Pontuação máxima e descritores
Náuseas/vômitos	0-7 (7 = vômitos constantes, ânsia)	Distúrbios táteis	0-7 (1 prurido leve ... 7 alucinações táteis contínuas)
Tremor (braços estendidos)	0-7 (1 não visível, sentido na ponta dos dedos ... 4 moderado ... 7 grave mesmo sem estender)	Distúrbios auditivos	0-7 (1 sons mais altos/assustadores ... 7 alucinações contínuas)
Sudorese	0-7 (1 palmas úmidas ... 4 gotas na testa ... 7 sudorese profusa)	Distúrbios visuais	0-7 (1 sensibilidade à luz ... 7 alucinações contínuas)
Ansiedade	0-7 (1 leve ... 4 moderada/reservado ... 7 pânico)	Cefaleia/pressão na cabeça	0-7 (não pontuar tontura)
Agitação	0-7 (1 um pouco mais que o normal ... 4 inquieto ... 7 anda de um lado a outro/se debate)	Orientação/obnubilção	0-4 (1 não sabe a data, hesita; 2 desorientado ≤ 2 dias; 3 > 2 dias; 4 desorientado em lugar/pessoa)
Total 0-67	<10 leve (geralmente sem medicação, observar); 10-18 moderada (medicar); $\geq 19-20$ grave (medicar agressivamente, internar; risco de DT)	Limitação	Exige paciente comunicativo; em delirium/intubado usar RASS/sinais vitais; não usar só para "não medicar" quem tem sinais autonômicos graves

2.2 Preditores de abstinência grave/complicada — PAWSS (≥ 4 = alto risco) e ASAM

Pontuar 1 cada: bebeu nas últimas 30 dias (ou etanol positivo); abstinência prévia; **convulsão de abstinência prévia**; **DT prévio**; internação por abstinência/tratamento prévio; blackouts; uso concomitante de BZD/barbitúrico/outra depressor; uso de outras substâncias; etanol sérico > 200 mg/dL com sinais de abstinência; sinais autonômicos na chegada (FC > 120 , PA $> 150/90$, tremor, sudorese). Também elevam o risco: idade > 65 , doença clínica aguda (infecção, trauma, cirurgia, pancreatite), hipocalemia/hipomagnesemia, plaquetopenia, TGO/TGP muito elevadas, longa duração de uso pesado.

2.3 Encefalopatia de Wernicke — suspeitar e tratar sem esperar confirmação [EFNS 2010; critérios de Caine]

2 de 4: (1) deficiência nutricional/etilismo pesado; (2) **alteração ocular** (nistagmo, paralisia do VI par/oftalmoplegia, ptose); (3) **ataxia/disfunção cerebelar** (marcha, coordenação); (4) **alteração do estado mental/confusão** ou perda de memória. A tríade clássica completa ocorre em $< 20\%$. Sem tratamento: coma, morte ($\sim 20\%$) ou síndrome de Korsakoff (amnésia permanente). **Tiamina IV em dose alta antes de glicose** (seção 7.2) — a suspeita basta; confirmação por RM é tardia/dispensável.

2.4 Diferenciais e comorbidades que mimetizam ou se somam

Condição	Pistas / conduta
Hipoglicemia	Glicemia capilar em todo etilista confuso/tremendo (Protocolo 13); tiamina junto
TCE / hematoma subdural	Queda, anticoagulação, déficit focal, confusão que não flutua como DT, sem sinais autonômicos → TC (Protocolo 29)
Infecção (pneumonia, PBE, meningite, sepse)	Febre alta persistente, foco; DT também dá febre — cultura/RX/líquor se dúvida (Protocolo 05)
Encefalopatia hepática	Cirrose, flapping, sonolência (não agitação autonômica), amônia; lactulose; BZD com cautela
Intoxicação alcoólica ou por outras drogas / abstinência de BZD	Hálito, nível de etanol, sedação × agitação; abstinência de BZD = mesmo tratamento
Cetoacidose alcoólica	Vômitos, jejum, ânion gap alto, cetonemia, glicemia normal/baixa → glicose + tiamina + volume (Protocolo 02/13)
Distúrbios eletrolíticos (Na, K, Mg, fósforo)	Hiponatremia (cerveja), hipoK/hipoMg (arritmia, convulsão), hipofosfatemia (realimentação) — Protocolo 24
Convulsão de outra causa	Focal, estado de mal, >48 h da última dose, TCE, sem sinais de abstinência → investigar (Protocolo 14)
Tireotoxicose, síndrome serotoninérgica/neuroléptica, psicose primária, delirium de outra causa	Contexto, exames, medicações

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais	Taquicardia, hipertensão, febre baixa (>38,5 = infecção?), taquipneia; instabilidade no DT
Tremor (mãos estendidas, língua), sudorese, hiperreflexia	Gravidade da abstinência (CIWA)
Sensório e orientação	Alucinação (orientado) × DT (desorientado, flutuante); Glasgow
Olhos	Nistagmo, oftalmoplegia (VI par), ptose → Wernicke
Marcha e coordenação	Ataxia → Wernicke/cerebelo; polineuropatia
Cabeça	Sinais de trauma (hematoma, Battle) — etilista cai
Estigmas de hepatopatia	Icterícia, aranhas, ascite, flapping, ginecomastia → cirrose (ajustar BZD)
Estado nutricional	Caquexia, glossite, queilite → risco de Wernicke/realimentação
Abdome	Dor epigástrica (pancreatite, gastrite), hepatomegalia
Pele	Desidratação, lesões, sinais de injeção
Risco de suicídio e violência	Protocolo 04 — sempre perguntar

4. Propedêutica armada

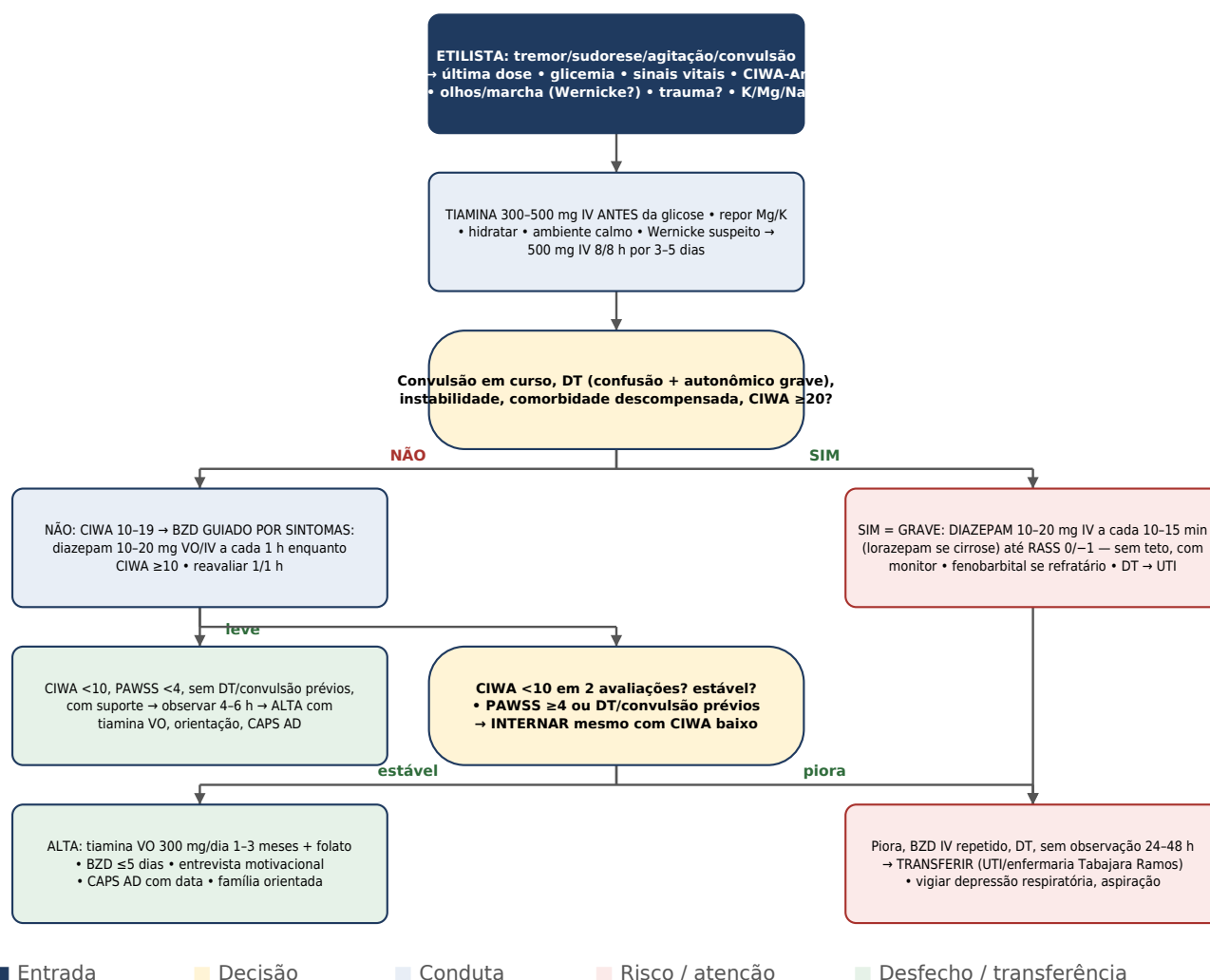
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Hipoglicemia	Todos, na triagem
Eletrólitos (Na, K, Mg, Ca, fósforo)	HipoK/hipoMg (repor — reduzem convulsão/arritmia), hiponatremia, hipofosfatemia (realimentação)	Todos moderados/graves
Hemograma, creatinina, TGO/TGP/GGT, bilirrubinas, INR, albumina, amilase/lipase, CPK	Hepatopatia (ajuste de BZD — lorazepam/oxazepam preferidos), plaquetopenia, pancreatite, rabdomiólise	Moderados/graves; internação
Etanol sérico / bafômetro	Abstinência com etanol ainda alto = alto risco; intoxicação × abstinência	Se disponível
Gasometria, lactato	Cetoacidose alcoólica, sepse	Vômitos, jejum, instabilidade
ECG	QT longo (hipoK/hipoMg), arritmia, isquemia	Moderados/graves, >40 anos
Radiografia de tórax	Pneumonia por aspiração, TB	Febre, tosse, hipoxemia
TC de crânio	Hematoma subdural, contusão	Trauma, déficit focal, convulsão atípica/focal, confusão que não melhora com BZD/tiamina, anticoagulado — referência
Urina I, culturas, líquido	Infecção como gatilho/diferencial	Febre persistente, sepse
Triagem toxicológica	Coingestão (BZD, cocaína)	Se disponível

5. Fisiopatologia

O etanol potencializa o receptor GABA-A (inibitório) e bloqueia o NMDA (excitatório). O uso crônico induz **neuroadaptação**: menos receptores GABA-A funcionais e mais receptores NMDA e canais de cálcio — o cérebro "compensa" o depressor com um estado excitatório latente. Ao cessar o álcool, a inibição some e a excitação glutamatérgica e noradrenérgica desabrocha: tremor, taquicardia, hipertensão, ansiedade, convulsões (excesso de NMDA) e, nos casos graves, o **delirium tremens** — hiperatividade autonômica extrema com confusão, hipertermia, desidratação, arritmias e morte cardiovascular. Os **benzodiazepínicos** restauram o tônus GABAérgico (tolerância cruzada) e são a única classe que reduz convulsão e DT; antipsicóticos baixam o limiar convulsivo e não tratam a causa. Cada episódio de abstinência não tratada facilita o seguinte (*kindling*): a gravidade cresce ao longo da vida. A **tiamina** é cofator da transcetolase e da piruvato-desidrogenase; o etilista desnutrido tem reservas para 2-3 semanas; uma carga de glicose sem tiamina consome o pouco que resta e precipita a necrose de estruturas periaquedutais e talâmicas — a encefalopatia de Wernicke. A hipomagnesemia (perdas renais pelo álcool) agrava a resistência à tiamina e a irritabilidade neuronal; por isso Mg e K se repõem junto.

6. Fluxo de atendimento [ASAM 2020; NICE; CIWA-Ar, adaptado]

Tiamina antes da glicose; benzodiazepínico guiado por sintomas, em dose suficiente; DT é UTI. Quem tem história de DT/convulsão interna mesmo com CIWA baixo.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → glicemia, CIWA-Ar, tiamina IV	≤30 min (tiamina antes de qualquer soro glicosado)
CIWA ≥10 → 1ª dose de benzodiazepínico	≤30 min; reavaliar CIWA a cada 1 h até <10 em 2 avaliações
Convulsão em curso → diazepam IV	Imediato (Protocolo 14)
DT / CIWA ≥20 com autonômico grave → BZD IV titulado + regulação para UTI	≤1 h
Suspeita de Wernicke → tiamina 500 mg IV	≤1 h; 8/8 h por 3-5 dias
Contato com CAPS AD antes da alta	Mesmo dia (documentar)

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Benzodiazepínicos — a base [ASAM 2020; NICE; ABP/ABEAD]

Estratégia	Esquema	Observações
Guiada por sintomas (preferida — menos BZD, menos tempo, sem perder eficácia)	Diazepam 10-20 mg VO/IV a cada 1 h enquanto CIWA-Ar ≥ 10 (ou lorazepam 2-4 mg VO/IV, ou clordiazepóxido 50-100 mg VO); reavaliar CIWA 1 h após cada dose; parar quando CIWA < 10 em 2 avaliações consecutivas	Exige enfermagem treinada em CIWA; a maioria precisa de 3-8 doses no 1º dia; se $> 100-200$ mg de diazepam/dia sem controle → refratária (fenobarbital, UTI)
Dose fixa + resgate (se não há como aplicar CIWA de hora em hora)	Diazepam 10-20 mg VO 6/6 h no dia 1 (40-80 mg/dia), 10 mg 6/6 h no dia 2, 10 mg 12/12 h dia 3, 5 mg 12/12 h dia 4, depois suspender + resgate 10 mg se CIWA ≥ 10	Risco de subdose (DT) ou sobredose (sedação); ajustar por reavaliação; nunca $> 5-7$ dias
Grave / DT	Diazepam 10-20 mg IV lento (2-5 mg/min) a cada 10-15 min até RASS 0 a -1 (calmo, despertável) — sem dose máxima predefinida (doses de 100-400 mg/dia são comuns); alternativa: lorazepam 2-4 mg IV a cada 10-15 min; midazolam 2-5 mg IV se sem outro	Monitor, oximetria, via aérea e flumazenil à mão (flumazenil raramente indicado — precipita convulsão); decúbito lateral; não usar IM (diazepam absorve mal); DT → UTI
Cirrose, idoso, DPOC grave	Lorazepam 1-4 mg (ou oxazepam) — sem metabólitos ativos, meia-vida menor	Diazepam acumula; doses menores e reavaliação frequente
Via	VO sempre que o paciente coopera e deglute; IV se CIWA $\geq 15-20$, vômitos, convulsão, DT	Sem IM
Duração	Geralmente 3-5 dias; não prescrever BZD ambulatorial além de 5-7 dias (dependência)	Retirada gradual

7.2 Tiamina e nutrição [EFNS 2010; ASAM 2020]

Situação	Dose	Observações
Todo etilista em abstinência / desnutrido / antes de glicose IV	Tiamina 300 mg IV (ou 100-300 mg IM/IV) por 3-5 dias , depois 100-300 mg VO/dia por $\geq 1-3$ meses	Diluir em 100 mL SF, infundir em 15-30 min (anafilaxia rara); antes ou junto da glicose — nunca a glicose primeiro; ampola 100 mg/mL [VERIFICAR estoque]
Suspeita de Wernicke (2 de 4 critérios de Caine)	Tiamina 500 mg IV 8/8 h (1,5 g/dia) por 3-5 dias → 250-300 mg/dia IV/IM por mais 3-5 dias → 100-300 mg VO/dia	Não esperar exame; melhora ocular em horas, ataxia/confusão em dias; sem resposta → outra causa; RM se disponível (ambulatorial)
Magnésio	MgSO ₄ 50% 2 g IV em 1-2 h (repetir; 4-8 g/dia se Mg baixo)	Corrige resistência à tiamina, reduz arritmia/convulsão
Potássio, fósforo, folato	KCl conforme Protocolo 24; fosfato se $< 1,5$ mg/dL; ácido fólico 5 mg/dia; polivitamínico	Síndrome de realimentação: introduzir dieta gradualmente
Hidratação e glicose	Cristaloide isotônico; SG só após tiamina; glicemia se hipoglicemia (Protocolo 13)	DT: perdas por sudorese/febre — 3-6 L/dia podem ser necessários; evitar hipotônicos
Dieta	Oral precoce, fracionada, rica em carboidratos complexos e proteína após estabilização	—

7.3 Adjuvantes e refratariedade

Fármaco	Uso	Cautelas
Fenobarbital	Refratária a altas doses de BZD (>100–200 mg de diazepam sem controle): 10–15 mg/kg IV (ataque em 30 min) ou 130–260 mg IV a cada 15–30 min até controle; ou como adjuvante inicial 10 mg/kg IV (Rosenson 2013: ↓ UTI)	Sedação profunda, depressão respiratória — monitor/UTI; sinergia com BZD; sem antídoto
Propofol / dexmedetomidina	DT refratário intubado (propofol) ou adjuvante para sintomas autonômicos (dexmedetomidina 0,2–1,4 mcg/kg/h) — não tratam a abstinência (não previnem convulsão)	UTI; dexmedetomidina não substitui BZD
Haloperidol	Alucinações/agitação psicótica persistentes após BZD adequado : 2,5–5 mg IM/IV	Baixa limiar convulsivo, QT, SNM; nunca isolado como tratamento da abstinência
Betabloqueador / clonidina	Adjuvantes para taquicardia/hipertensão persistentes após BZD (propranolol 10–40 mg; clonidina 0,1–0,2 mg)	Mascaram sinais de gravidade; não previnem convulsão/DT; evitar como monoterapia
Carbamazepina / gabapentina / valproato	Abstinência leve-moderada ambulatorial em pacientes selecionados (ASAM: opção); gabapentina 300–600 mg 8/8 h	Sem evidência em grave; não no PS como 1ª linha
Fenitoína	Não — ineficaz na convulsão de abstinência	—
Contenção mecânica	Só se risco iminente e após medicação, com as regras do Protocolo 04	Rabdomiólise, hipertermia — evitar

7.4 Convulsão e delirium tremens — condutas específicas

- **Convulsão de abstinência**: diazepam 10 mg IV (Protocolo 14); após cessar, iniciar/intensificar o esquema de BZD (a convulsão marca alto risco de DT); investigar TCE/hipoglicemia/hipoNa/hipoMg; convulsão focal, estado de mal, >48 h da última dose ou com déficit → TC (transferir). Sem fenitoína; sem antiepiléptico crônico se só de abstinência.
- **Delirium tremens**: sala de emergência, monitor, 2 acessos, BZD IV titulado até calma (sem teto), tiamina 500 mg, hidratação vigorosa, Mg/K/fósforo, resfriamento se >38,5 °C (e investigar infecção — hemocultura, RX, urina), glicemia, ECG; sonda vesical; profilaxia de aspiração (decúbito lateral, cabeceira); contenção só se necessário e breve; **UTI (Tabajara Ramos)** — transferir com BZD em curso e via aérea avaliada (IOT se não protege via aérea ou refratário).
- Óbito no DT: arritmia (hipoK/hipoMg/QT), hipertermia, aspiração, depressão respiratória por sedação sem monitor, complicação clínica não diagnosticada (sepse, pancreatite, HDA, TCE).

7.5 Alta e continuidade — o que não pode faltar

- Critérios de alta (abstinência leve/moderada): CIWA <10 sem BZD nas últimas 4–6 h (ou controlada com esquema oral decrescente definido), sem confusão, sinais vitais normais, sem convulsão em 24 h, tolera VO, sem comorbidade descompensada, acompanhante, sem risco alto de suicídio.
- Receita: **tiamina 300 mg/dia VO por 1–3 meses** + ácido fólico + polivitamínico; diazepam VO decrescente por no máximo 3–5 dias (10 mg 8/8 h → 12/12 h → 1x/dia) só se PAWSS alto e com supervisão; **não** prescrever BZD por semanas.
- **Entrevista motivacional breve** (5 min: escuta, perguntar sobre disposição para mudar, informar riscos sem julgamento, oferecer ajuda) e **encaminhamento ao CAPS AD com data** (acolhimento em ≤7 dias) — a abstinência é a janela; naltrexona/acamprosato/dissulfiram são decididos no CAPS/APS; grupos de apoio (AA) como opção.
- Orientar família: sinais de piora (confusão, convulsão, febre, alucinação) → retorno; não "dar uma dose para acalmar"; guardar medicamentos; risco de queda.
- Notificar se violência/tentativa de suicídio; comunicar a APS (ACS) para busca ativa se faltar ao CAPS.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Delirium tremens; abstinência refratária (BZD IV repetido sem controle; fenobarbital); via aérea comprometida; instabilidade; convulsões recorrentes/estado de mal	Imediata (BZD em curso, tiamina, monitor)	UTI — Tabajara Ramos
Abstinência grave (CIWA ≥ 20) ou moderada com PAWSS ≥ 4 / DT ou convulsão prévios, sem leito de observação 24–48 h no PS; Wernicke; comorbidade descompensada (pancreatite, pneumonia, HDA, cirrose descompensada, TCE)	Mesmo dia	Enfermaria — Tabajara Ramos (ou leito de desintoxicação da RAPS [VERIFICAR])
Convulsão atípica/focal, confusão que não melhora, trauma craniano	Imediata / mesmo dia	TC/neurocirurgia — referência (Protocolo 29)
Risco de suicídio alto, psicose persistente após tratamento	Após estabilização clínica	Psiquiatria/CAPS (Protocolo 04)
Leve/moderada controlada, sem fatores de risco, com suporte	Alta com CAPS AD em ≤ 7 dias	APS/CAPS AD

8.2 Transporte e documentação

- Monitor, oximetria, via aérea avaliada (IOT se necessário antes de sair), acesso, BZD disponível para dose durante o transporte, decúbito lateral/cabeceira, contenção conforme Protocolo 04 se indispensável.
- Relatório: hora da última dose, consumo habitual, CIWA seriado com horários, **doses totais de BZD (droga/via/hora)**, tiamina/Mg/K administrados, convulsões, sinais de Wernicke, glicemia/eletrolitos/exames, comorbidades, história de DT/convulsão, risco de suicídio, contato da família.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 O que o PS precisa ter

- Escala CIWA-Ar impressa/no prontuário com treinamento da enfermagem (aplicação horária); RASS para pacientes não comunicativos.
- Estoque: tiamina 100 mg/mL (≥ 30 ampolas — Wernicke consome 15/dia), diazepam VO 5/10 mg e IV, lorazepam VO/IV [VERIFICAR], midazolam, fenobarbital IV, MgSO_4 , KCl, ácido fólico, polivitamínico, glicose 50%, haloperidol.
- Leito de observação com monitor por 24–48 h ou fluxo pactuado de internação; contato e fluxo do CAPS AD de referência [VERIFICAR]; material de entrevista motivacional/folheto.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de etilistas com glicemia e tiamina administrada antes de glicose IV documentadas	100%
% com CIWA-Ar na chegada e reavaliação horária quando ≥ 10	$\geq 90\%$
% de CIWA ≥ 10 com BZD em ≤ 30 min; % de CIWA ≥ 20 com BZD IV titulado e regulação de UTI	$\geq 90\%$ / 100%
% com Mg/K dosados e repostos quando baixos	$\geq 90\%$
% com avaliação de Wernicke (olhos/marcha/confusão) documentada	$\geq 90\%$
% de altas com tiamina VO prescrita, sem BZD > 5 dias, e contato com CAPS AD documentado	$\geq 90\%$
Fenitoína para convulsão de abstinência; haloperidol/betabloqueador como monoterapia; DT sem monitor (eventos sentinela)	0
Convulsão/DT durante a internação no PS em paciente com CIWA/PAWSS não aplicados; óbito por DT (revisão de caso)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Guiada por sintomas x dose fixa	ASAM/NICE: guiada por sintomas preferida (menos BZD/tempo); dose fixa aceitável se não há como aplicar CIWA horária. Adotadas ambas com preferência pela guiada
Dose de tiamina	EFNS 2010: 200-500 mg IV 3x/dia na suspeita de Wernicke; NICE: 300 mg/dia profilático; alguns: 100 mg/dia (insuficiente). Adotado 300 mg/dia profilático e 500 mg 8/8 h na suspeita
Fenobarbital	Evidência crescente como adjuvante/1ª linha em alguns PS (Rosenson 2013; ASAM: opção em refratária). Adotado na refratária e como adjuvante em grave com monitor
Dexmedetomidina/propofol	Adjuvantes de UTI; não substituem BZD (não previnem convulsão). Adotado
BZD ambulatorial	ASAM: pode em leve/moderada com supervisão diária; risco de abuso/interação com álcool. Adotado ≤5 dias com critérios
Anticonvulsivantes (carbamazepina, gabapentina)	ASAM: opção em leve/moderada ambulatorial; não no PS como 1ª linha. Registrado
Diretriz brasileira (ABP/ABEAD)	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]; convergente nos princípios
CAPS AD, leito de desintoxicação, lorazepam IV	Disponibilidade/fluxo [VERIFICAR]

10. Referências

- American Society of Addiction Medicine. The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. J Addict Med 2020;14(3S Suppl 1):1-72.
- National Institute for Health and Care Excellence. Alcohol-use disorders: diagnosis and management of physical complications (CG100), 2010, atualizada 2017; Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management of harmful drinking and alcohol dependence (CG115), 2011.
- Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo CA, Sellers EM. Assessment of alcohol withdrawal: the revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale (CIWA-Ar). Br J Addict 1989;84(11):1353-1357. Maldonado JR, Sher Y, Ashouri JF, et al. The Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale (PAWSS). Alcohol 2014;48(4):375-390.
- Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, et al. EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol 2010;17(12):1408-1418. Caine D, et al. Operational criteria for the classification of chronic alcoholics: identification of Wernicke's encephalopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:51-60.
- Rosenson J, Clements C, Simon B, et al. Phenobarbital for acute alcohol withdrawal: a prospective randomized double-blind placebo-controlled study. J Emerg Med 2013;44(3):592-598. Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med 2014;371(22):2109-2113. Daepfen JB, et al. Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal. Arch Intern Med 2002;162:1117-1121.
- Laranjeira R, Nicastrí S, Jerônimo C, Marques AC. Consenso sobre a síndrome de abstinência do álcool (SAA) e o seu tratamento. Rev Bras Psiquiatr 2000;22(2):62-71; Associação Brasileira de Psiquiatria / ABEAD — diretrizes vigentes [VERIFICAR]. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.088/2011 (RAPS — CAPS AD).
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de abstinência alcoólica (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração